

➔ GRUPO 14

CASO CLÍNICO 9

Análisis del caso



Información personal de la paciente

Física

- Edad: 48 años.
- Procedencia: Lima.
- Lesión medular cervical C4 AIS A por proyectil de arma de fuego.
- Tiempo de evolución: 1 año.
- Dependencia total para AVD.
- Uso de silla de ruedas mecánica.
- Lesión por presión sacra grado III-IV.

Mental

- Lúcida y orientada.
- Cognición conservada.
- Lenguaje comprensivo y expresivo adecuados.

Social

- Dependencia económica.
- Requiere apoyo permanente de cuidadores.
- Hijo entrenado en cuidados, pero trabaja fuera de Lima.
- Necesita asistencia para traslados, higiene y manejo esfinteriano.

Emocional

- Requiere adaptación psicosocial.
- Pérdida de independencia funcional.
- Posible impacto emocional asociado a dependencia y cambios en el estilo de vida.

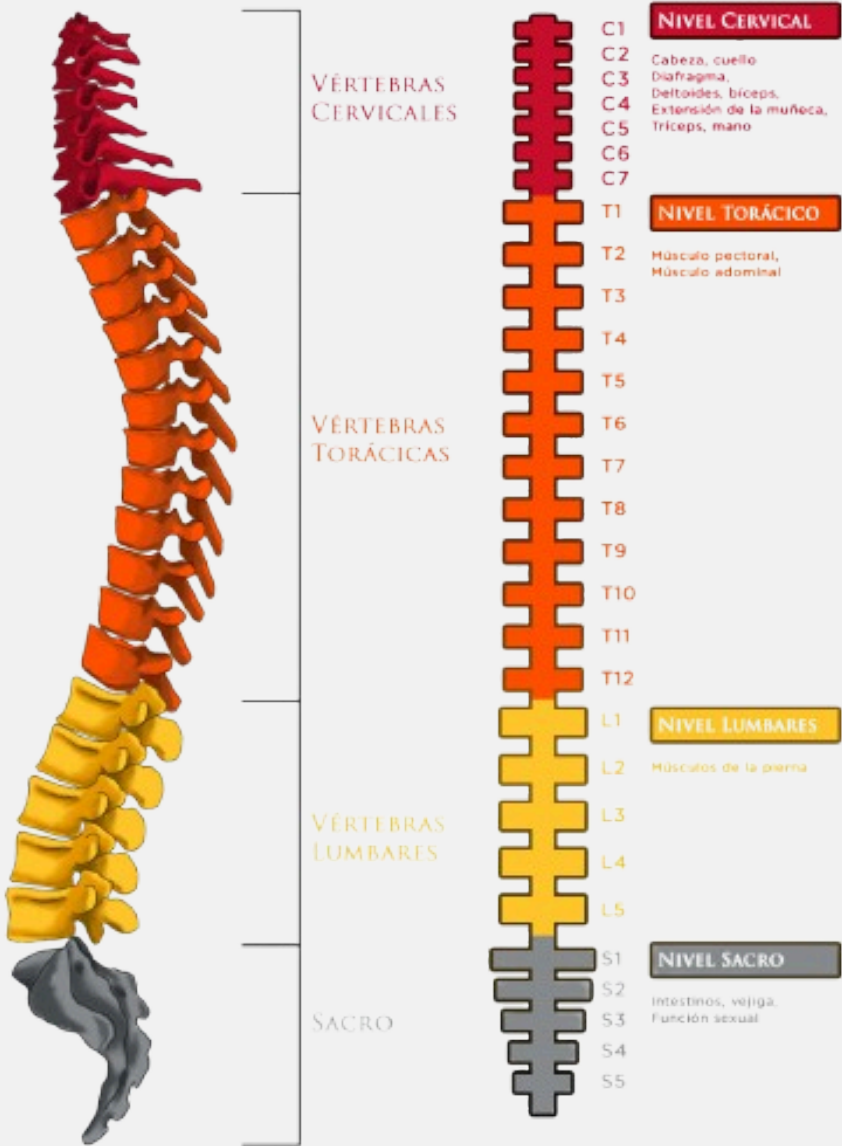
Información médica adicional

- Motivo de referencia: Rehabilitación integral.
- Especialistas involucrados: Medicina física y rehabilitación, enfermería, cirugía plástica, terapia ocupacional, fisioterapia.
- Tratamientos actuales: Rehabilitación funcional.

Diagnósticos e historial médico

Lesión medular cervical traumática completa.
C4, AIS A.

Nivel neurológico: C4
AIS A: pérdida de función sensitiva y motora



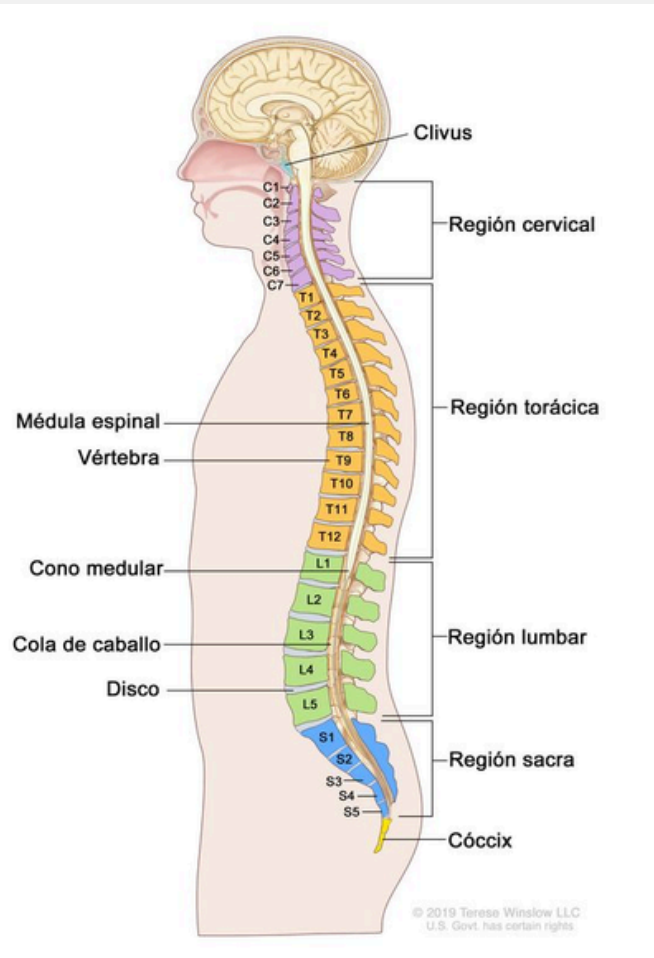
01

Rehabilitación
Favorecer la movilidad e independencia
Adaptación psicosocial del paciente.

02

Pronóstico y complicaciones
Neurológico: malo
Lesión por presión en la región sacra.

CLASIFICACIÓN DE ASIA (AMERICAN SPINAL INJURY ASSOCIATION)	
GRADO	CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
A LESIÓN COMPLETA	NO HAY FUNCIÓN MOTORA NI SENSITIVA POR DEBAJO DEL NIVEL NEUROLÓGICO.
B LESIÓN INCOMPLETA	NO HAY FUNCIÓN MOTORA DEBAJO DEL NIVEL NEUROLÓGICO, SENSIBILIDAD PRESERVADA
C LESIÓN INCOMPLETA	FUNCIÓN MOTORA DÉBIL (<3/5)*DEBAJO DEL NIVEL NEUROLÓGICO, SENSIBILIDAD PRESERVADA
D LESIÓN INCOMPLETA	FUNCIÓN MOTORA FUNCIONAL (>3/5)*DEBAJO DEL NIVEL NEUROLÓGICO, SENSIBILIDAD PRESERVADA
E NORMAL	FUNCIÓN SENSITIVA Y MOTORA NORMAL



Estado neuromuscular y musculoesquelético

01 ESTATURA Y PESO

Presenta impresión de sobrepeso.

02 ARTICULACIONES

Movilidad pasiva con leve disminución en flexión de hombros.

03 FUERZA MUSCULAR

- C5 3/3, puede flexionar el codo. De C6 a S1 plejía total. Flexión de codo 35°.
- Disminución de tono muscular en miembros superiores, leve incremento en miembros inferiores.(Ashworth 1).
- Presenta espasmos leves.

04 INFLUENCIAS NEUROLÓGICAS/ REFLEJOS

- Reflejos Osteotendinosos abolidos bilateralmente.
- Babinski, Clonus, signo de Beevor y contracción anal voluntaria ausentes.

05 POSTURA

Sin control activo de tronco para sedestación independiente o bipedestación. Se traslada en silla de ruedas mecánica neurológica con soporte de cojines.

06 CONTROL MOTOR Y MOVIMIENTOS

Movilidad activa muy disminuida en miembros superiores y nula en inferiores.

07 EVALUACIÓN

Requiere soporte externo total en tronco y pelvis para mantener la alineación debido a la ausencia de tono activo troncal.

Afección de la piel

Piel tibia, elástica, hidratada y en regular estado de higiene.



PRESENCIA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

- Ubicado en la región sacra, de grado III a IV, dimensiones aproximadas de 4x3 cm.
- Bordes levemente macerados, lecho limpio con secreción serohemática.
- A causa de pérdida total de sensibilidad bajo C4 y apoyo constante en sedestacion
- Recibe curaciones periódicas ambulatorias indicadas por Cirugía Plástica y manejo postural con cojines adaptados.

Función sensorial

La paciente presenta una lesión medular cervical completa (C4, AIS "A"). Esto implica una interrupción total de las vías sensitivas por debajo del nivel de la lesión. Su percepción sensorial está limitada a la cabeza, cuello y zona superior de los hombros, careciendo de sensibilidad táctil y dolorosa en el resto del cuerpo, lo que incrementa críticamente el riesgo de complicaciones dérmicas.

01

Sensibilidad superficial intacta únicamente hasta el nivel C4 bilateral (cabeza y cuello). Visión y audición conservadas sin alteraciones.

02

Pérdida total de sensibilidad (táctil, dolor y propiocepción) desde C5 hasta S5 de forma bilateral, incluyendo las extremidades superiores e inferiores.

03

El diagnóstico AIS "A" confirma la ausencia de función sensitiva (y motora) en los segmentos sacros (S4-S5). Carece de sensibilidad anal profunda.

04

La incapacidad para percibir presión o dolor sublesional impide detectar la isquemia tisular. Esta falta de "alerta" sensorial es la causa directa de la lesión por presión grado III-IV en la región sacra.

Habla, lenguaje y comunicación

01

A pesar de la severidad de la lesión medular (C4), las funciones corticales superiores no están afectadas. La paciente presenta un lenguaje expresivo y comprensivo adecuado. Su articulación y habla son claras y no presenta alteraciones en los pares craneales.

02

Su estado de conciencia es lúcido y se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona. Las áreas de cognición, atención, memoria y conducta están totalmente conservadas. El trauma afectó las vías motoras/sensitivas periféricas, no el encéfalo.

03

Debido a la preservación de sus facultades cognitivas y del habla, puede expresar sus necesidades verbalmente de forma independiente. No requiere de sistemas aumentativos ni dispositivos tecnológicos (como rastreadores oculares) para comunicarse eficazmente.

Desempeño funcional de habilidades y de tareas

ACTIVIDADES DE VIDA DIARIA

Dependencia total
La paciente requiere la presencia y asistencia permanente de un cuidador en todo momento.

VESTIRSE, BAÑARSE E HIGIENE

Falta de función motora activa por debajo de C5 le impide manipular prendas de vestir, cierres o botones, así como elevar el tronco o los miembros inferiores para vestirse.

MANEJO ESFINTERIANO

Pérdida de control de esfínteres (contracción anal voluntaria y sensibilidad anal profunda ausentes).
Requiere el uso permanente de pañal y sonda Foley para la evacuación vesical.

ALIMENTACION

Miotomas C6 a T1 con fuerza 0/0, ausencia de extensión de muñeca y prensión manual
La vuelven dependiente al momento de alimentarse

REHABILITACION

Presento problemas en las rutinas de rehabilitacion pues su estado psicologico le impedia colaborar con las terapeutas

USO DE TECNOLOGÍAS

La parálisis de los dedos de la mano le impide el uso convencional de teclados o pantallas táctiles.

Movilidad y equipo medico

Control del entorno

Luces, televisión, teléfono, cama, pueden ser controlados atreves de voz para la comodidad del paciente

MOVILIDAD

Aquí una grúa de transferencia puede ser muy útil para pasar:
cama - silla de ruedas
silla - cama
silla - baño



DESPLAZAMIENTO

Silla de ruedas especializada:
Respaldo postural
soporte lateral de tronco
Apoyacabezas



MANEJO DE VESICAL

Sonda Foley
Catéter que permanece dentro de la vejiga para permitir la salida continua de orina.



¡Muchas gracias!

